Les schémas du chapitre 17 à savoir refaire

24 schémas qui peuvent tomber à l'écrit (schéma à légender ou à construire) ou être demandés à l'oral E5. Chaque schéma est suivi de ce qu'il faut dire.

1. La chronologie des grandes études (17.3.1, figure 17.1 ; exercice 2 (figure 17.6) ; corrections CNED)

1	1998-1999 INCA 1	consommations, ≈ 3 000 personnes (agence qui a précédé l'ANSES)
2	2006-2007 INCA 2 et ENNS	consommations + premier examen de santé national
3	2009 NutriNet-Santé	cohorte en ligne de volontaires (EREN)
4	2014-2015 INCA 3	> 5 800 personnes de 0 à 79 ans ; rapport publié en 2017
5	2014-2016 Esteban	poids, taille, prélèvements, biosurveillance ; publié en 2017
6	Depuis 2024 Albane	SpF + ANSES ; pilote 16/9/2024, national juin 2025, cycles de 2 ans

Dire : CNED « INCA 3 (2015) » → recueil 2014-2015, publication 2017. « Tous les 7 ans » = écart observé ; Albane remplace INCA, ENNS et Esteban. Toujours 3 dates : recueil, publication, consultation.

2. INCA, Esteban, NutriNet-Santé, Baromètre, Albane (17.3.1 ; tableau de synthèse)

Étude	Organisme	Population	Recueil	Atout
INCA 3	ANSES	0-79 ans, représentatif	3 jours déclarés	consommations, risques
Esteban	Santé publique France	6-74 ans, représentatif	examen, prélèvements	corpulence mesurée
NutriNet-Santé	EREN	adultes volontaires	en ligne, répété	effectif, suivi, associations
Baromètre	Santé publique France	adultes, aléatoire	téléphone, internet	comportements, inégalités
Albane	SpF et ANSES	0-79 ans, représentatif	nutrition, santé, biosurveillance	tous les 2 ans

Dire : ANSES = INCA ; Santé publique France = Esteban. NutriNet ne donne pas de prévalence (volontaires : plus de femmes, plus diplômés).

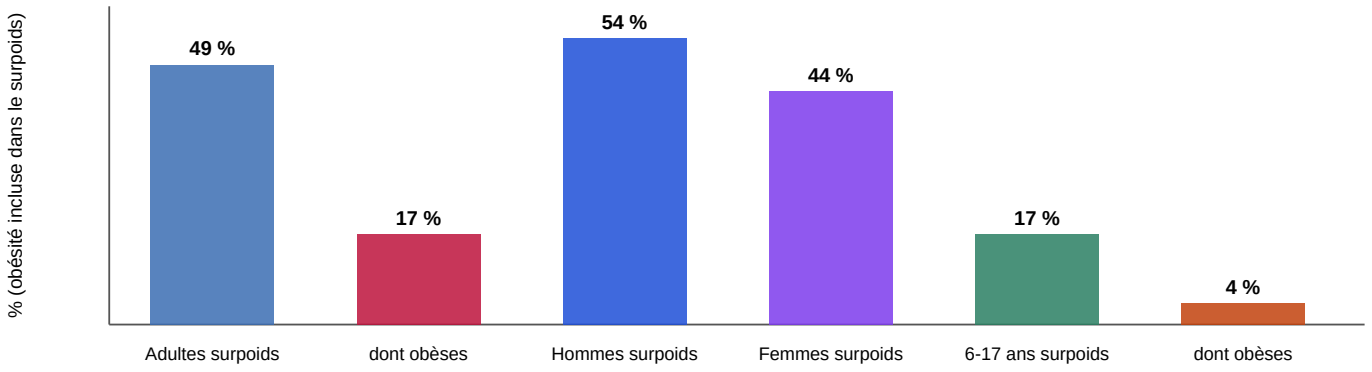
3. La méthode d'INCA 3 (17.3.1 ; 17.4.2 ; CNED M3 S1 § 1)



Codage avec la table Ciqual → nutriments ; questionnaires complémentaires (aliments rares)

Dire : jours espacés car deux jours qui se suivent se ressemblent ; recueil réparti sur l'année (saisons). Contribution : le pain est le premier contributeur du sel.

4. Les repères Esteban 2015 (mesurés) (17.3.1 ; repères datés)



Dire : « En 2015, 17 % des adultes de 18 à 74 ans étaient obèses (Santé publique France, Esteban, 2017 ; mesuré). » 49 % inclut les 17 % : jamais 66 %. Stable depuis l'ENNS 2006.

5. L'étude de l'alimentation totale (EAT) (17.3.1)



EAT 2 (2011) ; EAT infantile (2016)

Dire : une exposition n'est pas une maladie. Les enfants sont plus exposés par kg. Conseil : varier les espèces, marques et provenances.

6. Les cohortes françaises (17.3.1 ; exercice 17.7)

Cohorte	Début	Participants	Particularité
E3N	1990	≈ 100 000 femmes (MGEN)	cancers, alimentation
EPIC	1992	≈ 520 000, 10 pays	coordonnée par le CIRC
SU.VI.MAX	1994	≈ 13 000 adultes	essai puis cohorte
NutriNet-Santé	2009	volontaires en ligne	produits ultra-transformés, additifs
ELFE	2011	> 18 000 enfants	suivis depuis la naissance (Ined, Inserm)
Constances	2012	≈ 200 000 adultes de 18-69 ans	tirés au sort

Dire : point fort = chronologie (exposition avant la maladie) ; limite = confusion et volontaires. Appariement = rapprocher les données d'une même personne par un identifiant protégé.

7. Retraduire un titre de presse (17.3.1 ; exercice 17.8)

1	Quelle étude ?	nom, organisme, année
2	Quel type ?	cohorte, essai, transversale
3	Sur qui ?	volontaires ? représentatif ?
4	Risque relatif	RR 1,20 = + 20 % en relatif
5	Risque absolu	5 → 6 pour 1 000 = 1 cas de plus
6	Quel verbe ?	« est associé à », pas « provoque »

Dire : un risque relatif seul ne dit pas l'importance de l'effet. Nutri-Score : arrêté du 31/10/2017, logo facultatif.

8. Les publics mal couverts par les grandes enquêtes (17.3.1)

Aide alimentaire	Petite enfance	Personnes âgées	Outre-mer
• passages ≠ personnes • échelle d'insécurité • 4 800 / 230 = 20,9	• Enquête périnatale, Epifane • certificats 8e j (PMI) • taux de retour	• Esteban ≤ 74 ans • INCA 3, Albane ≤ 79 ans • logement ordinaire	• Esteban = métropole • Kannari 2013-2014 • ORS, ARS, Insee

Dire : ce sont souvent les publics du diététicien. On cherche des enquêtes spécifiques ou l'on fait ses propres observations, en le signalant. Ne pas transposer la métropole.

9. Albane : ce qui change (17.3.1 ; corrections CNED)

Avant	Avec Albane	Trois volets
• une enquête tous les 8-10 ans • INCA (ANSES) et Esteban (SpF) séparées • Esteban : 6-74 ans	• cycles de 2 ans • une enquête commune, mêmes personnes • 0-79 ans ; > 3 000 personnes	• nutrition (consommations, activité) • santé (examen, prélèvements) • biosurveillance (PFAS, phtalates…)

Dire : pilote le 16/9/2024 (Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine) ; national depuis juin 2025 ; recueil jusqu'à fin 2026 ; premiers résultats début 2028. Au 26/10/2026, rien de publié : on cite Esteban et INCA 3.

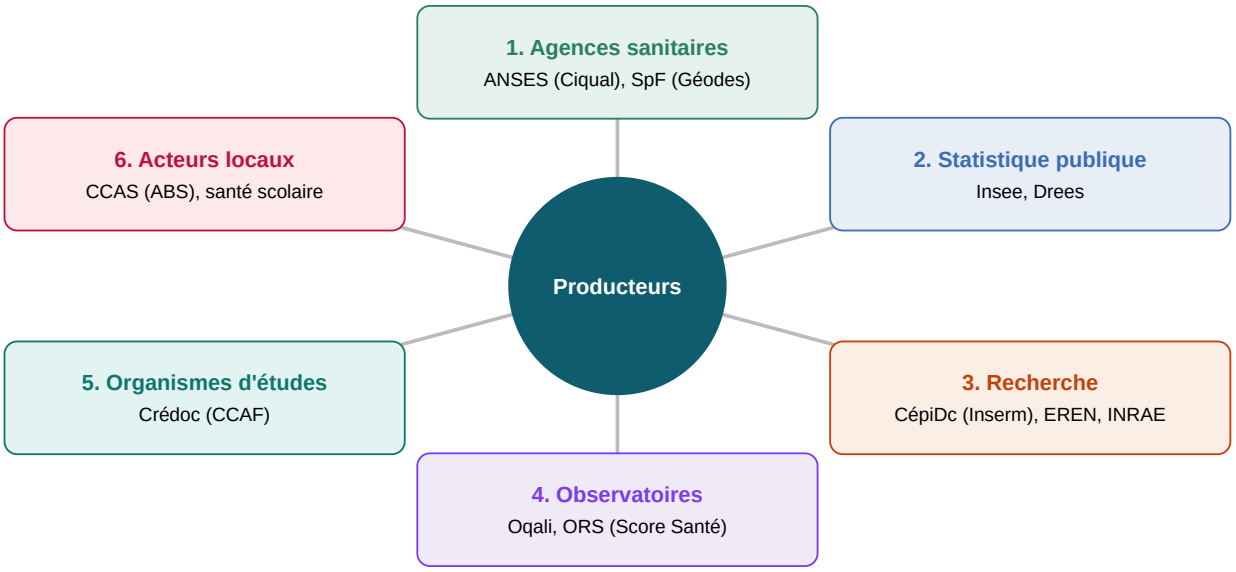
10. Organiser sa veille (17.3.1 ; exercice 17.15)

1. Lister	2. S'abonner	3. Rythme	4. Tracer	5. Dater
SpF, ANSES, Drees, Insee, ORS	lettres, flux	contrôle mensuel	date, source, nouveauté, action	« État de la veille au… »

Rapport (priorité) > synthèse > article, BEH, avis > presse (point d'entrée seulement)

Dire : un document sans date de veille ne permet pas de juger s'il est à jour. Sans source retrouvée, on n'utilise pas le chiffre.

11. Les producteurs de données (17.3.2, figure 17.3 ; exercice 1 (figure 17.5))



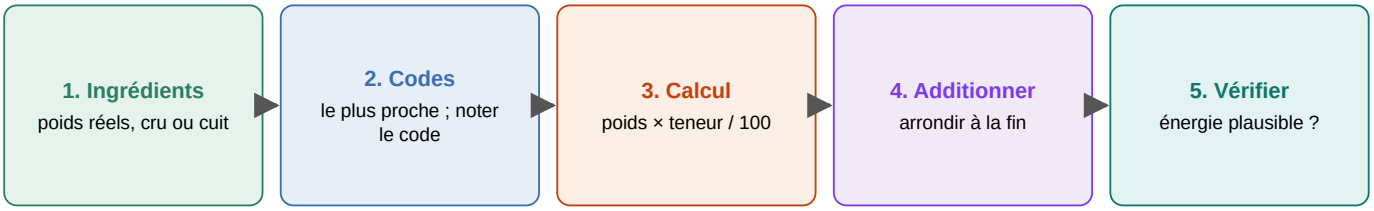
Dire : ANSES créée en 2010 ; SpF en 2016 ; Oqali en 2008 (INRAE + ANSES). Citer : organisme, titre, année des données, année de publication, date de consultation.

12. Lire une ligne de la table Ciqual (17.3.3 ; exercice 17.18)

On voit	Cela veut dire	On fait
2,7 g	teneur moyenne pour 100 g	vérifier l'état (cru, cuit, égoutté)
« < 0,5 »	sous la limite mesurable	compter 0 ou la moitié, en le disant
« traces »	présence non chiffrable	compter 0, en le disant
« - »	donnée manquante (non mesurée)	pas 0 : aliment proche ou limite signalée
aliment moyen	moyenne de variétés	si la variété est inconnue

Dire : pâtes sèches cuites 167 kcal contre crues 364 kcal pour 100 g : on prend le code de l'état pesé. Toujours citer la version (Ciqual 2025).

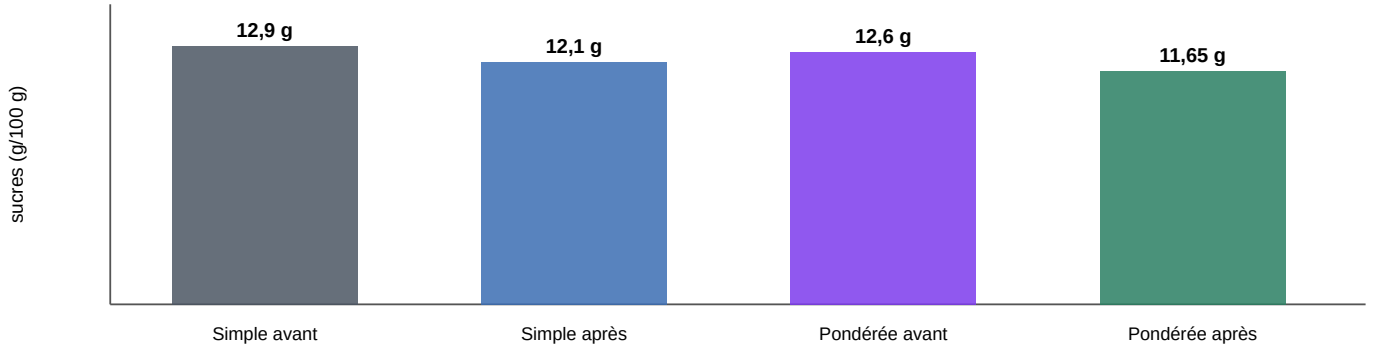
13. Calculer une recette avec Ciqual (17.3.3 ; exercices 17.19 et 17.20)



6. Citer : « Ciqual 2025 (ANSES) ; < et traces comptés 0 »

Dire : omelette 340 g = 362,6 kcal, lipides 49,4 % de l'énergie. Étiquette pour un produit de marque précis (céréales : 11,2 g contre 9,0 g de sucres avec Ciqual).

14. Oqali : moyenne simple ou pondérée (17.3.3 ; exercice 17.21)



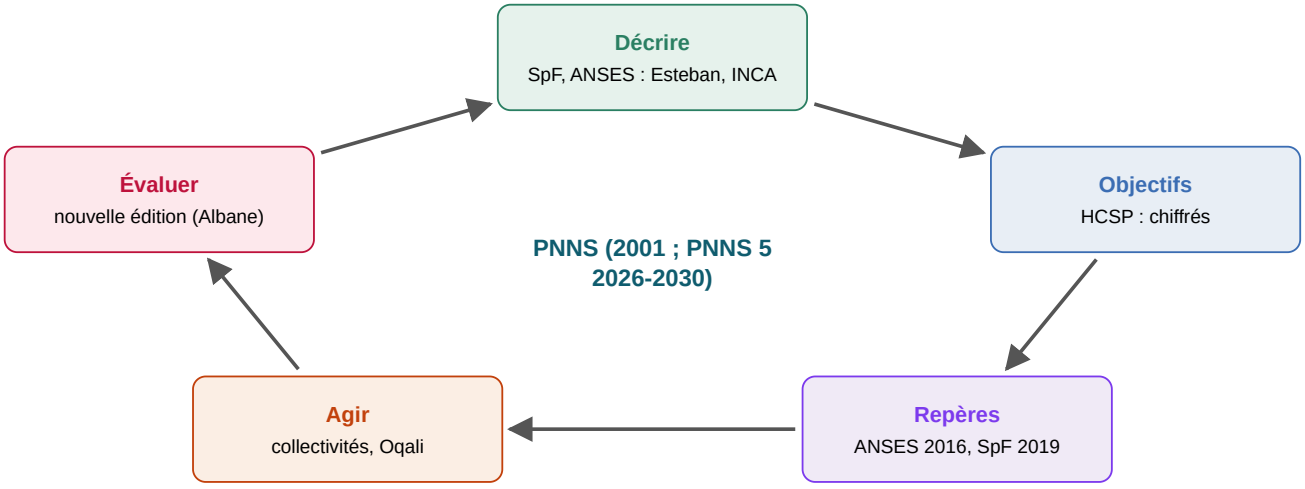
Dire : la baisse pondérée par les ventes (− 7,7 %) dépasse la baisse simple (− 5,8 %) car les produits reformulés sont les plus vendus. L'offre n'est pas la consommation.

15. Les dispositifs de vigilance (17.3.3 ; exercice 17.23)

Dispositif	Ce qu'il recueille	Pour le diététicien
Nutrivigilance (ANSES)	effets des compléments, aliments enrichis	signaler un effet suspect
Toxicovigilance	intoxications (champignons, plantes)	alertes saisonnières
MDO (ARS, SpF)	TIAC, infections alimentaires	enquête en restauration
RappelConso	produits retirés de la vente	vérifier, retirer, informer

Dire : un signalement spontané sert à alerter ; il ne donne pas de fréquence (sous-déclaration, exposés inconnus) et n'est pas une preuve.

16. Des données aux politiques (17.3.3)



Dire : objectif chiffré = indicateur + valeur cible + échéance, avec mesures de départ et d'arrivée comparables. PNNS 5 lancé le 8/4/2026.

17. Les textes de la restauration collective (17.3.3 ; exercice 17.31)

Texte	Ce qu'il fixe
Décret et arrêté du 30/9/2011	scolaire : fréquences sur 20 repas, grammages, eau à volonté, pas de sel en libre accès
GEMRCN (2015)	repères de fréquences et grammages par population
Loi EGalim n° 2018-938 du 30/10/2018	≥ 50 % durables et de qualité dont ≥ 20 % de bio ; menu végétarien hebdomadaire
Télédéclaration des cantines	achats publiés, données ouvertes

> Dire : vérifier le texte en vigueur sur Légifrance et dater. Les menus disent ce qui est servi, pas ce qui est mangé : compléter par la pesée des restes.

18. BNM ou RNP ? (17.3.3 ; exercice 17.32)

BNM

- couvre la moitié
- % sous le BNM = part à risque
- 58 / 200 = 29 %

RNP

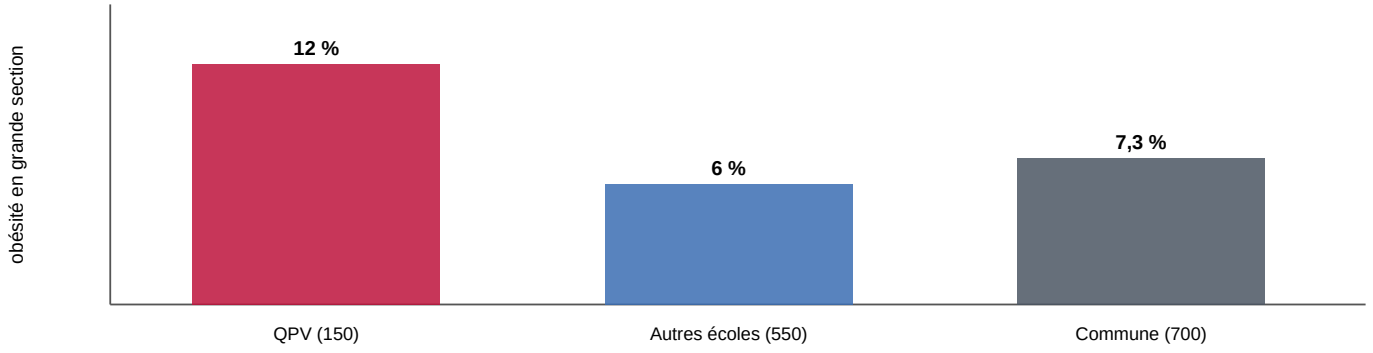
- couvre ≈ 97,5 %
- pour conseiller une personne
- plus élevée que le BNM

AS

- apport satisfaisant
- quand pas de BNM
- ANSES 2016

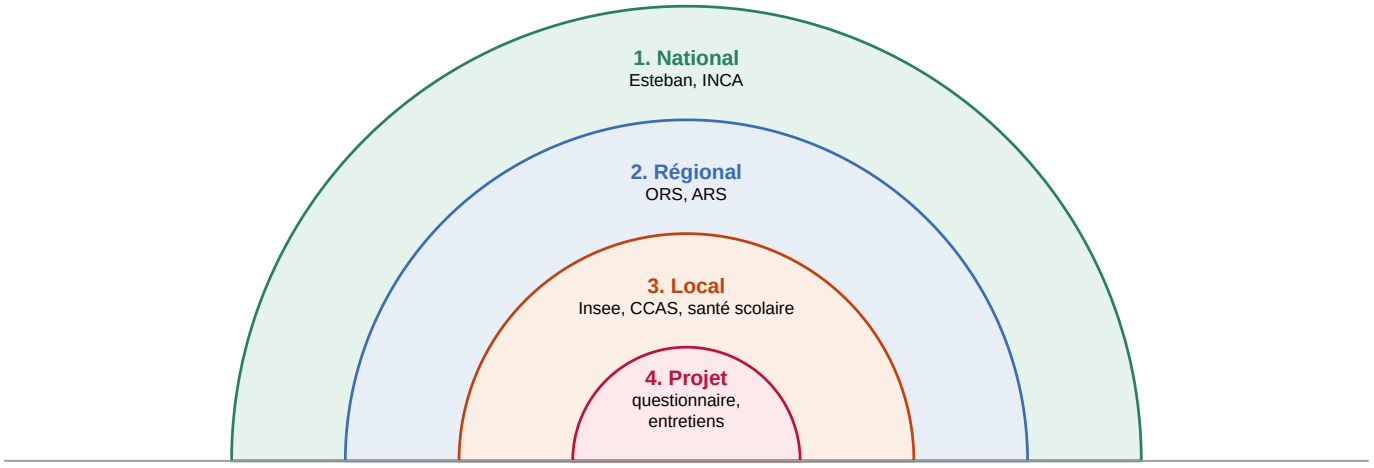
> Dire : une moyenne au-dessus de la RNP peut cacher des personnes sous le BNM. Il faut des apports habituels : un seul jour élargit la distribution.

19. Écart relatif, écart absolu, où sont les enfants ? (17.3.3 ; exercice 17.34)



> Dire : × 2 et 6 points d'écart, mais 33 des 51 enfants (65 %) sont hors QPV → universalisme proportionné : action pour tous, renforcée dans le QPV. Ne pas stigmatiser.

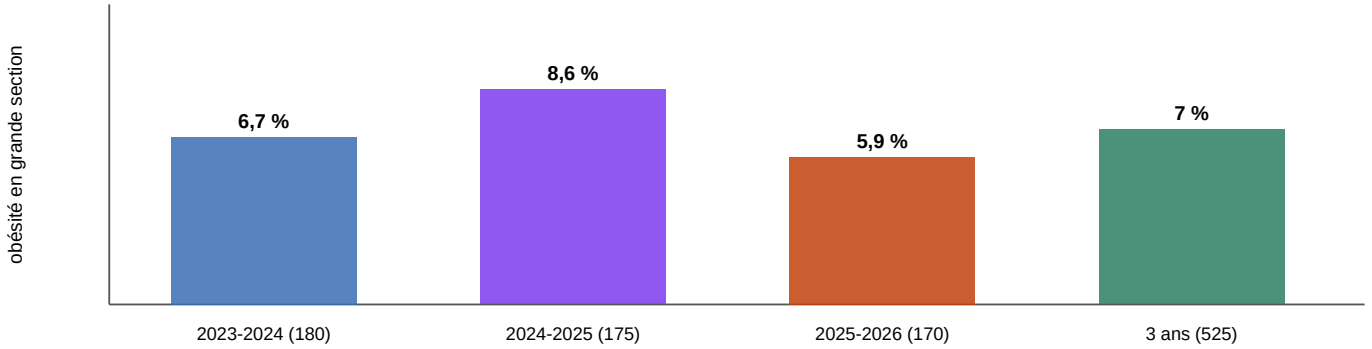
20. Les niveaux du diagnostic (17.3.3, figure 17.4 ; exercice 3 (figure 17.7))



Un chiffre national appliqué au territoire = ordre de grandeur

> Dire : Valmont 29 000 × 0,17 = 4 930 adultes « si la commune ressemblait à la moyenne ». Citer la source à chaque niveau et préciser déclaré ou mesuré.

21. Petits effectifs : regrouper les années (17.3.3 ; exercice 17.38)



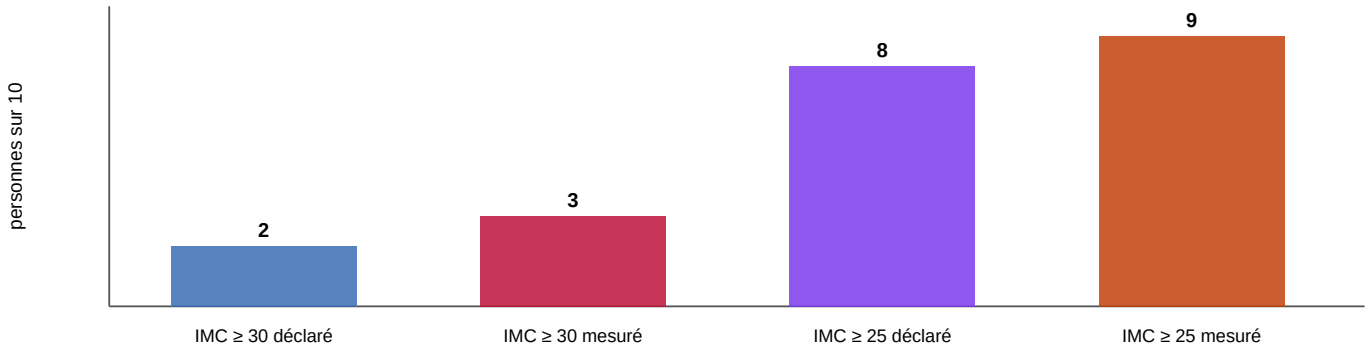
> Dire : 8,6 % [4,4 ; 12,7] et 5,9 % [2,3 ; 9,4] se recouvrent : pas de baisse démontrée. Regroupé : 7,0 % [4,9 ; 9,2]. Condition : n × p et n × (1 − p) ≥ 5.

22. Tableau croisé : en ligne ou en colonne ? (17.3.3 ; exercice 17.40)

Diplôme des parents	Sans petit-déjeuner	% en ligne	% en colonne
Sans diplôme	42 / 78	53,8 %	30,4 %
CAP à bac	65 / 185	35,1 %	47,1 %
Supérieur	31 / 170	18,2 %	22,5 %
Total	138 / 433	31,9 %	100 %

> Dire : en ligne = dans chaque groupe, quelle part ? En colonne = parmi les concernés, d'où viennent-ils ? Se demander toujours : quel dénominateur ?

23. Déclaré ou mesuré (17.4.1 ; exercice 17.45)



Dire : poids sous-déclaré (− 2,8 kg), taille surestimée (+ 1,15 cm) → obésité sous-estimée. On compare du déclaré à du déclaré (Baromètre), jamais à Esteban sans le dire.

24. Le SNDS et ses limites (17.4.4 ; exercice 17.50)

Contenu	Accès	Ne voit pas
• Assurance maladie • hôpitaux, causes de décès • loi du 26/1/2016	• données agrégées ouvertes • accès permanents, sur projet • Health Data Hub (24/7/2019)	• poids, alimentation, revenu • maladie non diagnostiquée • « traité » ≠ « diabétique »

Dire : donnée pseudonymisée = toujours personnelle (RGPD), car ré-identifiable. Rupture de série : un saut dû à un changement de méthode (question, mode, table).